校园用药生存课

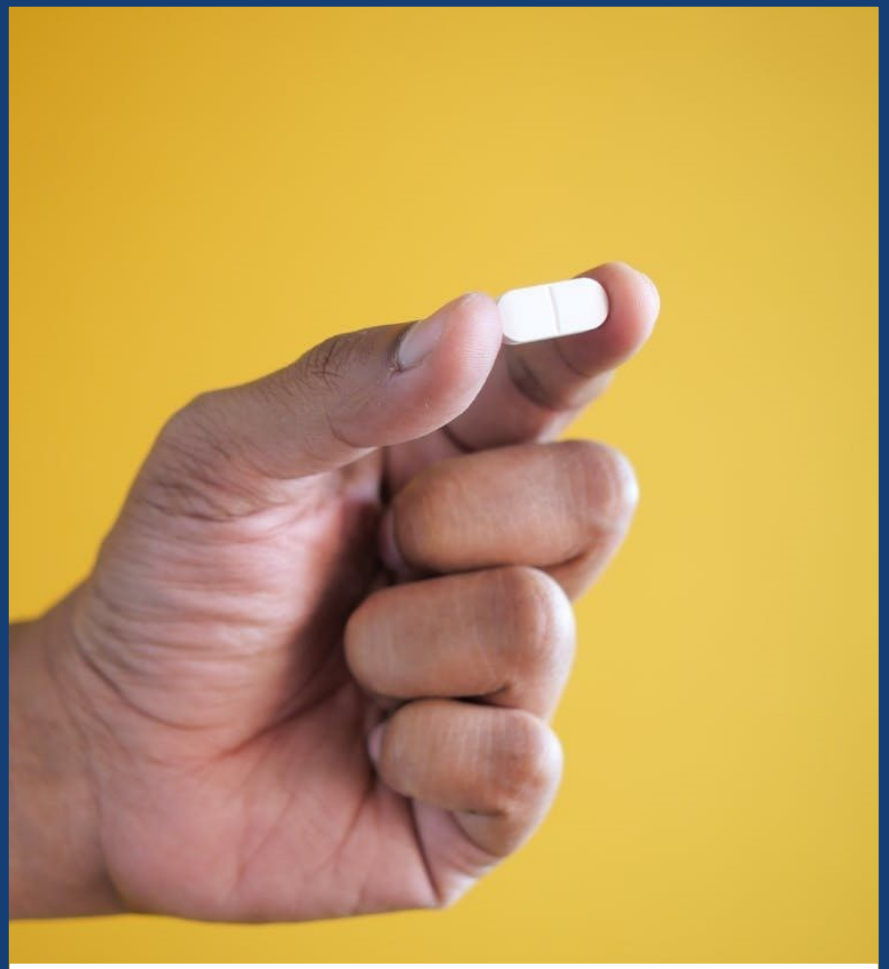
合理用药

给宿舍药箱上堂课

会选药 · 看成分 · 避误区

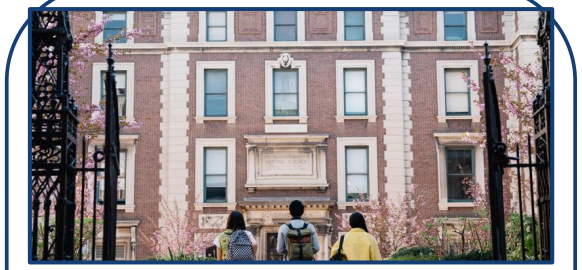
苏州大学｜选修课课堂展示
主讲：同学甲 / 同学乙

35 分钟 · 2 位讲者 · 4 部分



真实照片 · 场景示意

今天的路线：从会判断，到会行动



01

基本原则

5 分钟



02

宿舍误区

17 分钟



03

安全用药

8 分钟



04

选择挑战

5 分钟

全程约 35 分钟，已包含举手互动。

室友感冒了，你先做哪一步？

A 用上次的剩药，沿用当时吃法

B 拍清楚药盒，先核对再作决定

C 按最主要症状，先挑一盒试试

先选哪一步？

单选



想一想，再举手

举手选择 A / B / C ｜暂不揭晓

合理用药，要同时过四关

01 安全

关注禁忌与不良反应

02 有效

针对真正需要解决的问题

03 经济

避免不必要的花费

04 适宜

适合这个人、这个时机

刚才选 B：先了解，再决定。

来源：S1 · 完整链接见附页

鼻子舒服了，为什么上课却犯困?

鼻子舒服了



终于不用一直擦鼻涕!

鼻部

组胺参与部分过敏反应

部分症状得到缓解

上课却犯困?



鼻子好了，
脑子想“下课”……

脑内

组胺信号参与维持清醒

部分药物入脑后可能致困

选药别只看症状：查嗜睡提示，说清上课与通勤需求

症状缓解，不代表没有其他影响 | 先查嗜睡提示

来源： S8 · 完整链接见附页

两盒药，是“双保险”还是撞车？

01 情境

头痛还在，要不再加一盒？



先有一个需求

02 对话

名字不同，应该不重复吧？



再来一个建议

03 悬念

药盒不同，里面的成分呢？

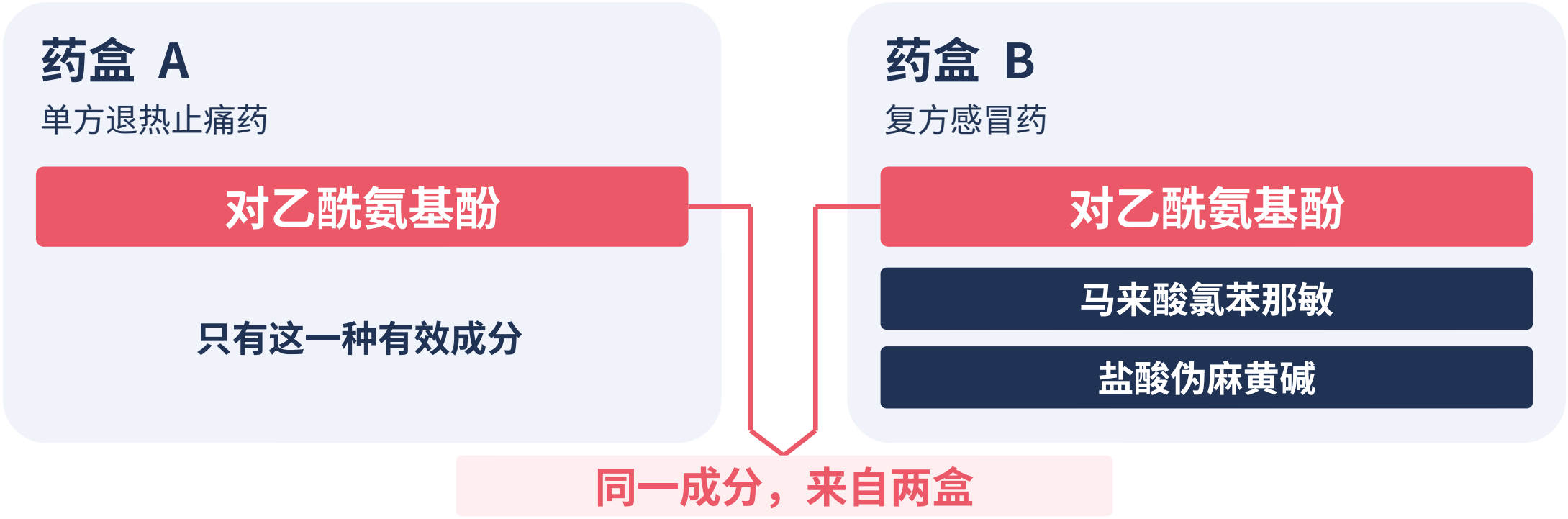


判断停在这里

虚构情境｜包装不同，成分可能重复。

来源： S2 · 完整链接见附页

药盒不同，成分可能“撞车”



① 圈出重复 → ② 核规格与已服情况 → ③ 未确认，不自行叠加

同名成分出现两次，是暂停核对的信号｜未确认前不自行叠加

来源： S2 · 完整链接见附页

18 点吃过药，20 点还痛：先补哪条信息？

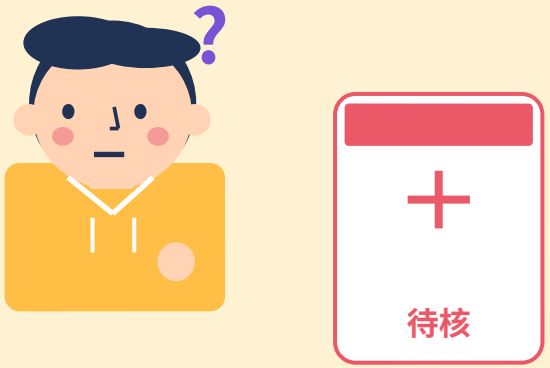
18:00



已经服过

已经服过一种复方感冒药

20:00



准备再加

症状还在，准备加一盒退热药

先补信息

药名＋成分

规格＋已服用量

时间＋其他用药

核对后再决定

成分、规格、已服用量还没核对

时间只是故事线索，不是推荐给药间隔｜先补信息，不凭感觉加药

来源： S2 · 完整链接见附页

室友群的三条消息，你给哪条点赞？

A 拍下两盒成分，圈出相同的名字

B 按症状拆开安排，把服药时间错开

C 补上今天已服药名、规格与时间

给建议点赞

可多选



想一想，再举手

可多选 A / B / C ｜哪些建议先帮我们补齐判断所需的信息？

来源： S2 · 完整链接见附页

答案 A + C：先把两类信息凑齐

A + C

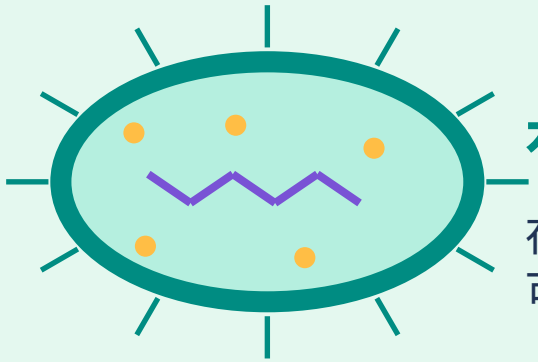
- A 圈出同名成分，发现可能重复
- C 补规格和已服记录，核对累计使用
- B 错开时间，仍不能代替完整核对

同成分先不自行叠加；拿着完整信息，再核实下一步。

来源： S2 · 完整链接见附页

案例②：抗生素，不是感冒的通用答案

细菌

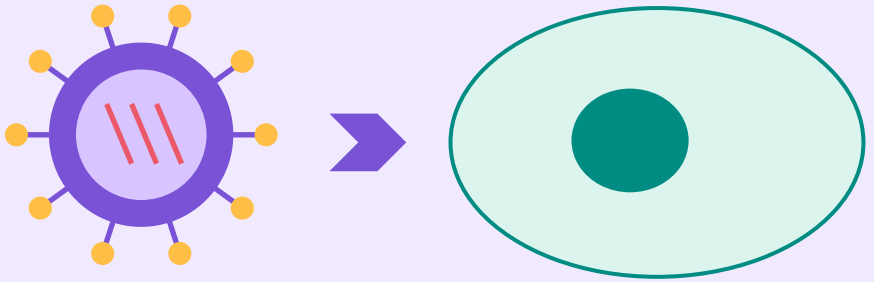


有细胞结构

在适宜条件下
可自行繁殖

某些细菌结构或过程
可成为抗生素的靶点

病毒



宿主细胞

无细胞结构
依赖宿主细胞复制

普通感冒通常由病毒引起；是否需要抗生素，由医生判断。

来源： S4; S11 · 完整链接见附页

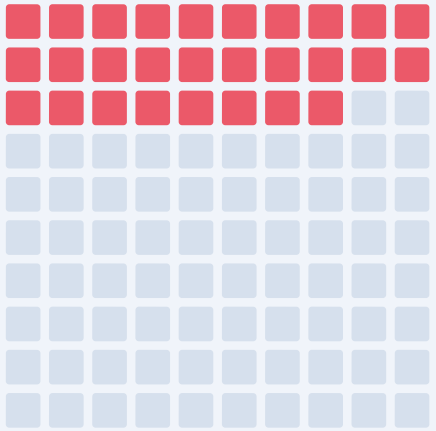
不需要的抗生素，也可能带来真实伤害

不必要的抗生素处方

美国门诊 · 2014—2015 估计

至少

28%



每格＝ 1% 处方；红色标出 28%

其余格子不表示都合理

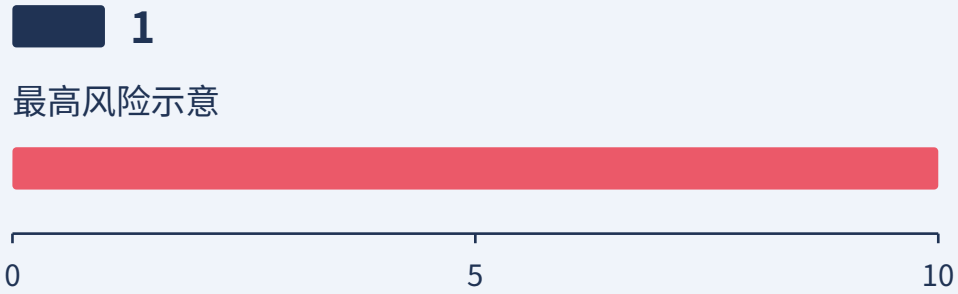
艰难梭菌感染风险

可引起腹泻、结肠炎

最高 10 倍

抗生素使用期间及结束后 1 个月

比较基准＝ 1



28% 是处方比例， 10 倍是风险上限说明；口径不同，不能相乘或推算个人概率。

来源： S5; S15; S16 · 完整链接见附页

把“别乱吃抗生素”，换成三个动作

01



先确认需要

感冒症状，不自动等于要用抗生素

02



不接室友剩药

相似症状，不代表同一病因

03



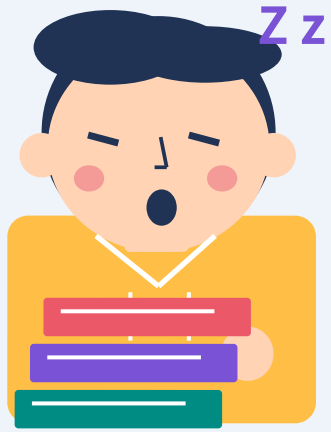
按处方执行

疗效或反应有疑问，及时咨询

先确认需要，再按具体处方使用；有疑问及时联系医生或药师。

来源： S4 • 完整链接见附页

案例③：鼻子舒服了，上课却困了



鼻子舒服了，
老师讲哪儿了？

症状缓解 ≠ 人人都不困

先查

说明书中的嗜睡提示

再说

白天有课、需要通勤等需求

已经困

避开驾驶、骑车等高风险活动

“较少嗜睡”不等于人人不困；第一次使用时尤其留意个人反应。

来源：S8 · 完整链接见附页

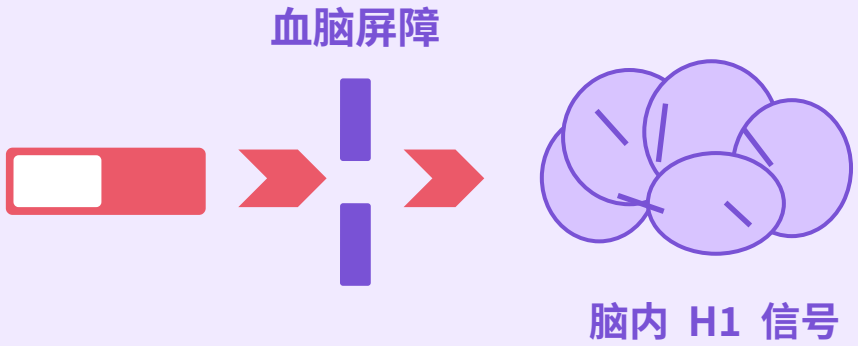
同一种组胺信号，为什么有两种影响？

鼻部：参与过敏反应



影响受体作用 → 缓解部分症状

脑内：也参与维持清醒



部分药物可进入脑内

清醒相关信号受影响 → 可能嗜睡

这是简化机制图；不能据此自行换药。

来源： S8; S14 · 完整链接见附页

聚餐邀请到了，你先回哪条消息？

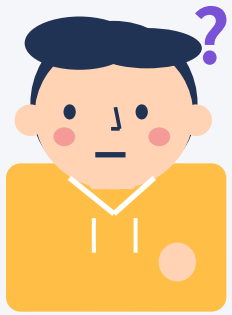
A 先吃点东西，把两者错开两小时

B 照以前的经验，只小酌不碰烈酒

C 今晚先换白水，按具体药名查要求

先选哪一步？

单选



想一想，再举手

单选｜今天服过抗过敏药，具体饮酒要求未确认；下一页再揭晓。

来源： S8; S9 · 完整链接见附页

案例④：聚餐这杯酒，先停一下

白天

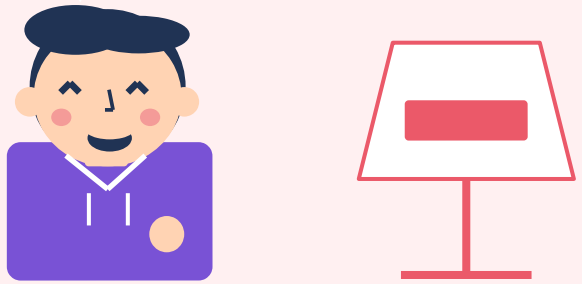
已经服过抗过敏药



先记住药名

晚上

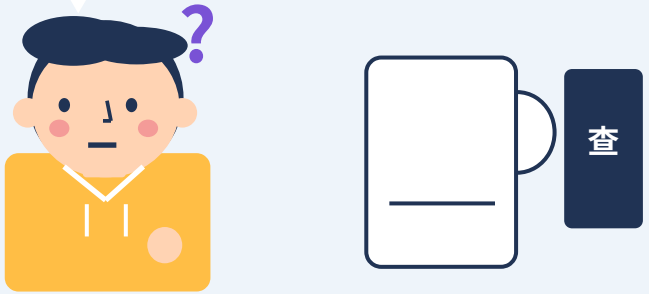
室友劝：就喝一点，没事吧?



劝酒不是依据

行动

暂换白水，核实具体药品要求



白水＋核实

刚才选 C：拿不准就先不喝；错开两小时、酒量好都不能代替核实。

来源： S8; S9; S13 · 完整链接见附页

安全用药四步：看、核、问、记

看

症状、说明书、就医信号

核

成分、剂量、间隔、禁忌

问

医生 / 药师，确认不确定处

记

药名、时间、用量与反应

刚才选 C ｜把“不确定”变成一个咨询动作。

来源： S1; S2; S8; S9 · 完整链接见附页

说明书很长？先定位这六处

1. 成分 / 通用名
2. 适应证或功能主治
3. 用法用量
4. 禁忌与注意事项
5. 相互作用 / 不良反应
6. 贮藏条件 / 有效期



真实照片 · 场景示意

请以手中的真实说明书为准

六处是阅读起点，不代表其余内容可以跳过。

来源： S1; S2; S8 · 完整链接见附页

时间、剂量、剂型，都别凭感觉改



01

漏服

先查具体处理要求，不自行加倍



02

疗程

按处方执行，有问题及时咨询



03

剂型

缓释、肠溶等，不随意掰碎

不同药物要求不同；不要套用同一条补药规则。

来源： S10; S13; S4 · 完整链接见附页

问药师时，把信息一次说清



真实照片 · 场景示意

- 我有什么症状，持续多久？
- 我正在吃什么，何时吃了多少？
- 我有哪些过敏史、疾病或特殊情况？

带药盒 / 说明书照片，比“那种白色药片”更有用。

来源： S2; S1 · 完整链接见附页

什么时候，不该继续自己试药?

120

严重急症
立即求助

呼吸困难 / 喉舌肿胀 / 意识异常

立即急救

疑似超量或误服

及时寻求医疗帮助

症状持续、加重或反复

及时就诊



真实照片 · 场景示意

严重急症拨打 120；带上药品信息，别等“自己好”。

来源： S2; S11; S12 · 完整链接见附页

宿舍药箱：留信息，也留秩序



真实照片 · 场景示意

- 原包装＋说明书｜一起保留
- 有效期＋贮藏条件｜定期检查
- 个人用药记录｜不混装、不分享处方药

数量不求多；需要时能认清、查到、说清。

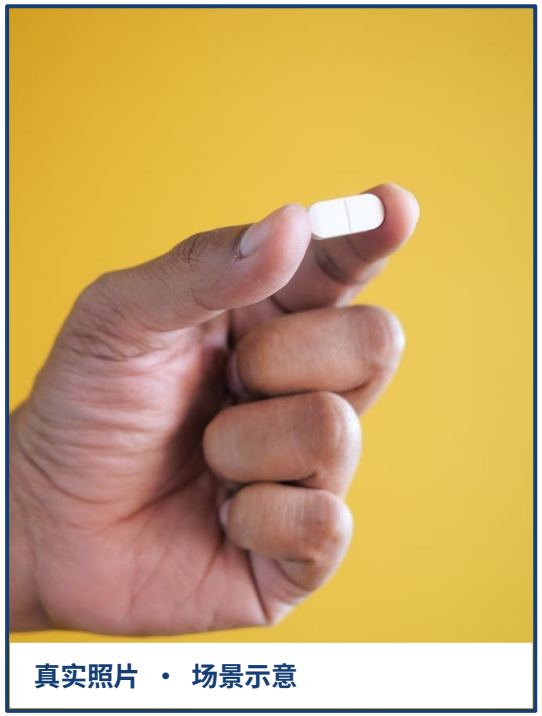
来源： S2; S4 · 完整链接见附页

把四个误区，换成四个动作

01	感冒药叠加	›	核对成分
02	感冒吃抗生素	›	先确认是否需要
03	抗过敏后困倦	›	查提示、避高风险活动
04	吃药后聚餐	›	先核实饮酒要求

看、核、问、记：现在进入简单挑战。

综合挑战：小苏今晚怎么安排？



真实照片 · 场景示意

已服：一种复方感冒药

准备：再加一盒药＋参加聚餐

当前：成分没核对，症状尚轻

虚构情境｜无呼吸困难、意识异常等急症表现。

小苏的晚间计划，你采纳哪几条？

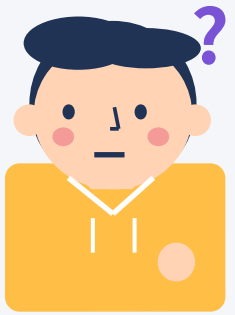
A 聚餐先点白水，具体饮酒要求再查

B 药盒和已服记录，一起交给药师核对

C 照上次的经验，把第二盒改到睡前

给建议点赞

可多选



想一想，再举手

可多选 A / B / C ｜逐条判断；想 10 秒，再举手

答案 A + B：把建议拼成完整行动

A + B

- A 饮酒要求未明 → 先用白水，再查询
- B 药盒与已服记录 → 一起核对，再决定
- C 沿用经验错开时间 → 信息缺口仍在

若症状加重或出现急症信号，应及时就医。

来源： S2; S4; S9; S11; S12 · 完整链接见附页

把判断带回生活

药可以常备，
判断不能省略。

先看说明书，再做用药决定

核对重复成分，记录已服药物

拿不准，问医生 / 药师

会看 · 会核 · 会问 · 会记



真实照片 · 场景示意

谢谢大家